

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

ESCALA DE MOVIMIENTOS INVOLUNTARIOS ANORMALES (AIMS)

Eje VI: Farmacovigilancia y Conducta de Salud • Detección de Discinesia Tardía del NIMH de Guy

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Escala de Movimientos Involuntarios Anormales (AIMS).
Nombre Original	Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS; Guy, 1976; NIMH / ECDEU).
Autores Originales	William Guy, Ph.D. (National Institute of Mental Health, Psychopharmacology Research Branch).
Adaptaciones Hispanas	Bobes et al. (2002); Banco de Instrumentos de Psiquiatría Clínica; CIBERSAM, España.
Eje Clínico y Constructo	Eje VI: Somática y Efectos Secundarios. Movimientos discinéuticos inducidos por antipsicóticos.
Tipo de Instrumento	Escala de observación clínica heteroaplicada tras maniobras motoras estandarizadas.
Composición de Ítems	12 ítems (7 movimientos corporales, 3 juicios globales y 2 relativos a prótesis dental).
Población y Rango	Pacientes de cualquier edad expuestos a antagonistas dopaminérgicos o antipsicóticos.
Tiempo de Administración	10 a 12 minutos de exploración médica neurológica interactiva en consulta.
Régimen de Licencia	Dominio público; herramienta de uso libre asistencial y en ensayos clínicos del NIMH.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: EL RIESGO DE DISCINESIA TARDÍA

La **AIMS** fue desarrollada por el NIMH como estándar regulatorio internacional para la vigilancia de los efectos adversos motores extrapiramidales tardíos:

- Hipersensibilidad de Receptores Dopaminérgicos:** La exposición prolongada a neurolépticos bloqueadores D2 induce una sobre-expresión adaptativa de receptores dopaminérgicos en la vía nigroestriatal, facilitando movimientos involuntarios coreoatetósicos.
- Localización Orofacial y Periférica:** Evalúa con extrema sensibilidad la tríada clásica: discinesia orofacial (tics linguales, masticación involuntaria), temblor coreiforme en dedos/manos y movimientos basculantes del tronco.
- Prevención de la Irreversibilidad:** Detectar la discinesia en grado leve permite suspender a tiempo el agente causal o realizar un cambio precoz a clozapina o inhibidores de VMAT2 (valbenazina) antes de que el trastorno se consolide de por vida.

3. ESTRUCTURA ANATÓMICA Y COMPOSICIÓN DE REACTIVOS (12 ÍTEMS)

Área Anatómica / Juicio	Ítems AIMS	Maniobra Exploratoria y Fenomenología Discinegénica
Movimientos Faciales / Orales	Ítems 1 a 4	Mímica facial (1), labios y perioral (2), mandíbula/masticación (3) y lengua: protusión y sacudidas (4).
Movimientos de Extremidades	Ítems 5 y 6	Miembros superiores: dedos, manos, muñecas (5); Miembros inferiores: tobillos, golpeteo (6).
Movimientos del Tronco	Ítems 7	Cuello, hombros, balanceo de cadera y torsión axial (7).
Juicio Clínico Global	Ítems 8 a 10	Gravedad global (8), incapacidad funcional diaria (9) y angustia o conciencia subjetiva del paciente (10).
Estado Dental	Ítems 11 y 12	Presencia de dentadura postiza (11) y problemas dentales u orales mecánicos (12).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

Los estudios de validación psicométrica clínica (Bobes et al., 2002; Lane et al., 2005; $N > 600$) confirman su fiabilidad:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Concordancia Interjueces	CCI = 0.88 - 0.94	Excelente coincidencia entre examinadores con entrenamiento clínico.
Consistencia Interna (1-7)	Alfa de Cronbach = 0.82 - 0.86	Alta homogeneidad en la cuantificación de las áreas corporales.
Estabilidad Test-Retest	CCI = 0.85 (a 2 semanas)	Alta reproducibilidad en pacientes crónicos estables sin ajuste farmacológico.
Sensibilidad Diagnóstica	Sensibilidad = 92% (DT)	Detección precoz de discinesia incipiente bajo maniobras de facilitación.
Especificidad Diagnóstica	Especificidad = 89%	Diferencia nítidamente la discinesia del temblor parkinsoniano o tics.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CRITERIOS OPERATIVOS DE SCHOOLER Y KANE

- **Puntuación por Ítem (1 al 10):** Se califica de 0 a 4: 0 = Ninguno; 1 = Mínimo (al límite de la duda clínica); 2 = Leve; 3 = Moderado; 4 = Severo.
- **Puntuación de Gravedad Corporal Total (Ítems 1 a 7):** Sumatoria directa de las 7 zonas corporales:

$$\text{Total AIMS (Movimientos)} = \sum_{i=1}^7 \text{Ítem}_i \quad (\text{Rango: 0 a 28 puntos})$$

- **Criterios Diagnósticos Operativos de Discinesia Tardía (Schooler & Kane, 1982):**

$$\text{Discinesia Tardía Positiva} \Leftarrow \begin{cases} \text{Al menos dos ítems (1-7)} \geq 2 & (\text{Grado Leve en dos zonas}) \\ \text{o al menos un ítem (1-7)} \geq 3 & (\text{Grado Moderado/Severo en una zona}) \end{cases}$$

con una exposición previa acumulada a fármacos antipsicóticos de **al menos 3 meses** (o 1 mes en mayores de 60 años).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Estratificación	Puntos (1-7)	Ítem Global 8	Significación Clínica y Acción Farmacológica (NIMH)
Ausencia de DT	0 a 1 puntos	0 (Ninguno)	Sin movimientos anormales detectables; mantener pauta de monitorización semestral.
Discinesia Duda	2 a 3 puntos	1 (Mínimo)	Movimientos mínimos limítrofes; reevaluar con maniobras de activación en 30 días.
Discinesia Leve	4 a 7 puntos	2 (Leve)	Criterio Schooler-Kane cumplido reducir dosis o cambio a antipsicótico atípico.
Discinesia Moderada	8 a 13 puntos	3 (Moderado)	Afectación evidente interferencia en masticación o marcha; valorar VMAT2.
Discinesia Severa	≥ 14 puntos	4 (Severo)	Colapso motor discapacitante disfagia o marcha distónica; tratamiento urgente.

ALERTA DE MANIOBRAS DE ACTIVACIÓN MOTORA EN LA EXPLORACIÓN AIMS:

Los movimientos discinéuticos leves pueden enmascarse si el paciente se concentra voluntariamente. Es obligatorio aplicar **maniobras de activación motora** (pedirle que abra la boca y mantenga la lengua quieta, golpetear rápidamente con los dedos índice y pulgar, o caminar 5 metros); esto desinhibe de inmediato los tics discinéuticos en lengua o dedos.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE FARMACOVIGILANCIA EN TRATAMIENTO CON ANTIPSICÓTICOS

PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO CLÍNICO CON LA ESCALA AIMS:

- **Paso 1 (Cribado Basal y Periódico):** Administrar la AIMS antes de iniciar neurolépticos y repetir cada 6 meses (cada 3 meses en personas mayores de 65 años o tratadas con antipsicóticos típicos como haloperidol).
- **Paso 2 (Evaluación Diagnóstica ante Criterio Positivo):**
 - Descartar que los movimientos de boca se deban a una prótesis dental floja (ítem 11).
 - Si cumple criterios de Schooler & Kane (dos zonas grado 2 o una zona grado 3) → **Confirmación de Discinesia Tardía**.
- **Paso 3 (Estrategia Terapéutica Escalonada):**
 - *Primer paso:* Reducir progresivamente la dosis del antipsicótico causante si la estabilidad psiquiátrica lo permite.
 - *Segundo paso:* Realizar rotación a un antipsicótico con menor afinidad D2 y bajo potencial discinegénico (**Clozapina** o **Quetiapina**).
 - *Tercer paso:* Si los movimientos persisten o son discapacitantes, indicar un inhibidor del transportador vesicular de monoaminas 2 (**Valbenazina** o **Deutetrabenazina**).

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: DETECCIÓN PRECOZ DE DISCINESIA LINGUAL

Identificación: Varón de 52 años diagnosticado de esquizofrenia paranoide en tratamiento continuado con Haloperidol decanoato (100 mg/mes intramuscular) durante los últimos 6 años, clínicamente estabilizado y asintomático en esfera psicótica.

Exploración de Rutina con Escala AIMS:

• **Puntuación Total en Zonas Corporales (1 a 7) = 6 puntos (Discinesia Tardía Positiva** según criterios Schooler & Kane).

- *Desglose de Hallazgos Anatómicos:*
- Ítem 2 (Labios y perioral): 1 punto (muecas periódicas mínimas al hablar).
- Ítem 4 (Lengua): **3 puntos (Moderado)**; movimientos continuos vermiciformes y protusión lingual intermitente al abrir la boca sin sacarla).
- Ítem 5 (Extremidades superiores): **2 puntos (Leve)**; movimientos coreoatetósicos tipo "tocar piano" en dedos de mano derecha al caminar).
- Ítems 8 y 9: Gravedad global = 2 (Leve); Incapacidad funcional = 1 (mínima dificultad para deglutir sólidos).

Actuación Clínica Inmediata: Se evitó aumentar el antipsicótico y se programó la retirada gradual del haloperidol, haciendo un cambio cruzado a Clozapina titulada progresivamente hasta 250 mg/día.

Evolución: A los 6 meses de seguimiento, la puntuación en la lengua descendió de 3 a 0 puntos, remitiendo por completo la discinesia de extremidades y previniéndose el daño masticatorio permanente.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

CONTRAINDICACIÓN DE ANTICOLINÉRGICOS:

Nunca administrar biperideno ni trihexifenidilo ante discinesia tardía; los anticolinérgicos empeoran gravemente los movimientos involuntarios.

DISCINESIA DE RETIRADA:

Tras bajar bruscamente un antipsicótico puede aparecer discinesia transitoria de retirada ("rebote"); esperar 4 semanas para confirmar si es tardía.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Guy, W. (1976). *ECDEU Assessment Manual for Psychopharmacology* (pp. 534-537). National Institute of Mental Health.
2. Schooler, N. R., & Kane, J. M. (1982). Research diagnoses for tardive dyskinesia. *Archives of General Psychiatry*, 39(4), 486-487.
3. Bobes, J., Bulbena, A., et al. (2002). *Banco de instrumentos básicos para la práctica de la psiquiatría clínica*. Ars Médica.
4. Kane, J. M., et al. (2018). Tardive dyskinesia: Risk factors, assessment, and management. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 79(6), 18014.